Implantaten ter vervanging van één of meerdere tanden of kiezen

Inleiding

Binnenkort ondergaat u een operatie om één of meerdere implantaten aan te laten brengen ter vervanging van één of meerdere tanden en/of kiezen. Op deze implantaten krijgt u in een latere fase een kroon of brug. Hieronder leest u meer informatie over de gehele behandeling.

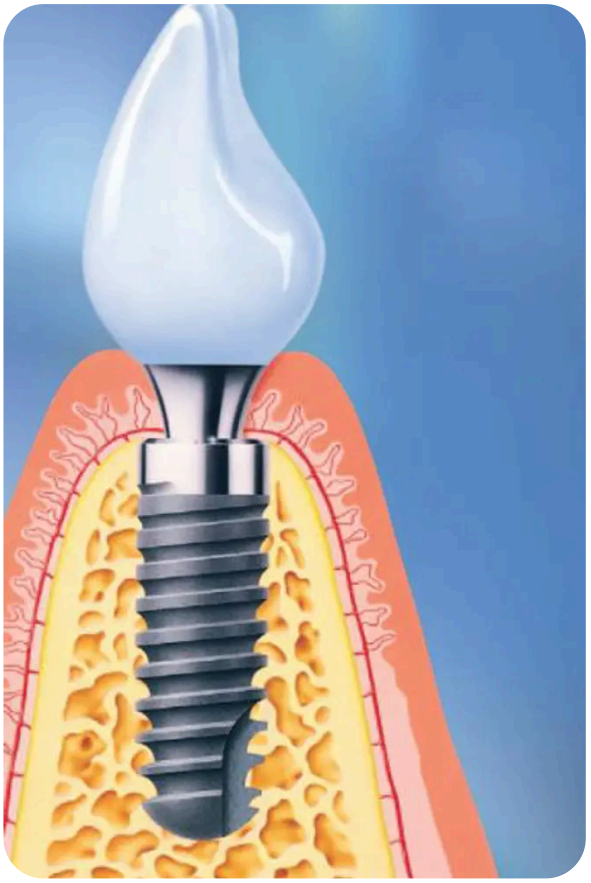
Gedurende de behandeling krijgt u te maken met een team van behandelaars van de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Bijzondere Tandheelkunde van het HagaZiekenhuis en/of uw huistandarts. De behandelaars zijn:

- Een MKA-chirurg (kaakchirurg): verzorgt de operaties en plaatst de implantaten.
- Een tandarts: maakt het kunstgebit op de implantaten.
- Een mondhygiënist: geeft aanwijzingen over uw mondverzorging.
- Assistenten: assisteren bij de operaties en de tandheelkundige behandeling.

Wat is een implantaat?

Als een tand of kies verloren is gegaan, zijn er meerdere mogelijkheden om ze te vervangen. Uw tandarts heeft dit met u besproken.

Als u een vaste voorziening wenst, is een implantaat vaak een goede mogelijkheid. Op het implantaat kan later een kroon of brug worden geplaatst.



Implantaat

Welke operaties zijn nodig?

Soms is op de plek van de te vervangen tand of kies een tekort aan kaakbot, zodat het niet mogelijk is direct een implantaat aan te brengen. Dit tekort aan bot moet dan eerst worden aangevuld.

Gering tekort aan bot

Als het tekort gering is, kan het bot (tijdens het plaatsen van het implantaat) iets worden aangevuld. In de directe nabijheid van het geplaatste implantaat kan daarvoor botschraapsel worden geoogst.

Een andere mogelijkheid is kunstbot te gebruiken. Dit is vaak verkregen van bewerkt runderbot. Dit materiaal is volledig veilig en goed wetenschappelijk onderzocht. Ook een combinatie kunstbot en eigen bot is mogelijk. Dit kan rondom het implantaat worden aangebracht. In 1 operatie worden dan het tekort aan bot aangevuld en het implantaat geplaatst.

Aanzienlijk tekort aan bot

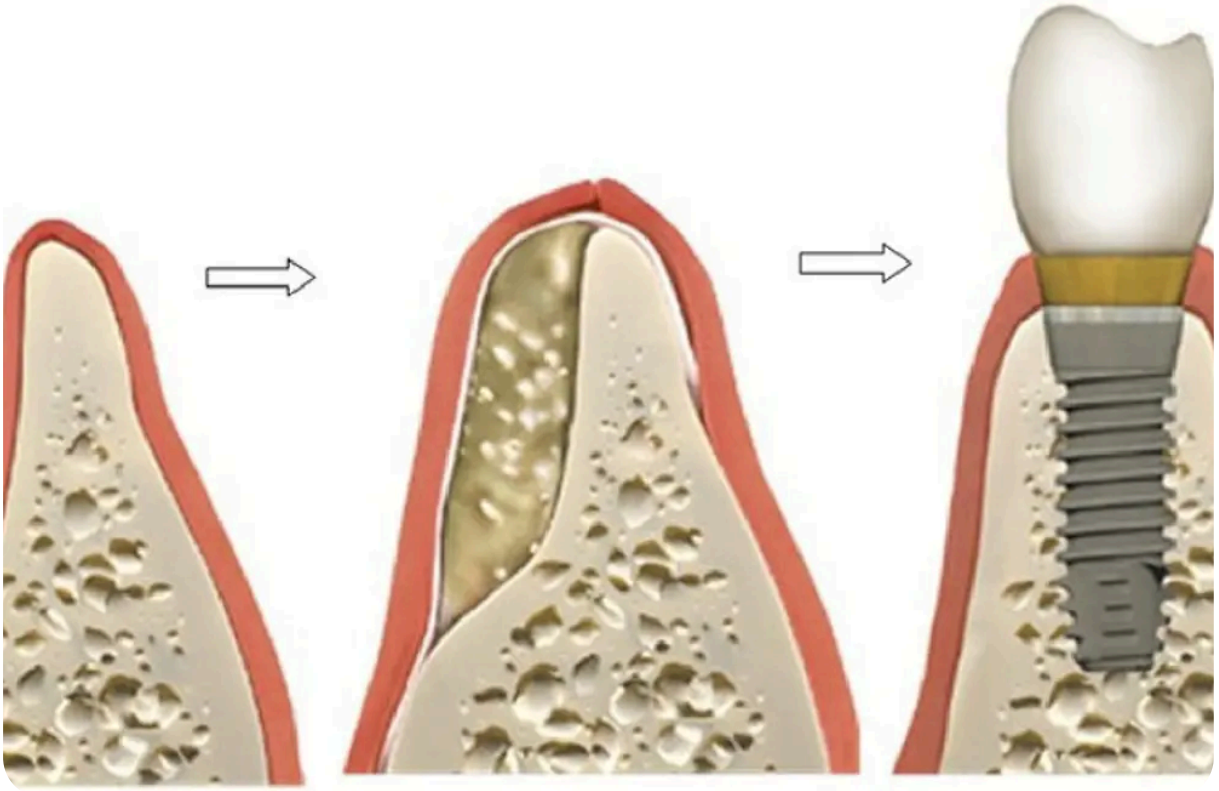
Als het tekort aan bot aanzienlijk is, kan elders in de kaak een klein stukje bot worden weggehaald. Tijdens deze eerste operatie wordt het ‘geoogste’ bot geplaatst op de plek waar het implantaat gepland is. Soms wordt in plaats van lichaamseigen bot gebruikgemaakt van kunstbot. Er zijn ook combinaties van kunstbot en eigen bot mogelijk.

Het geoogste bot wordt meestal vastgezet met een klein titanium schroefje. Na 3 tot 4 maanden is het aangebrachte bot goed vastgegroeid en kan het implantaat worden ingebracht. Dit gebeurt tijdens een tweede operatie.

Plaatsen van implantaat

Voor het plaatsen van het implantaat wordt het tandvlees opzij geschoven om het kaakbot zichtbaar te maken. In het kaakbot wordt een gaatje geboord ter grootte van het implantaat. Hierna kan het implantaat worden geplaatst. Op het implantaat wordt een afdekdopje geschroefd. Tenslotte wordt het tandvlees gehecht. Het afdekdopje van het implantaat is dan vaak niet meer zichtbaar.

De operaties worden gedaan onder plaatselijke verdovingen en duren ongeveer 1 uur.



Hoe gaat de behandeling verder?

Het aangebrachte implantaat wordt soms ‘verstopt’ onder het tandvlees, zodat het rustig kan vastgroeien. Na 6 tot 8 weken wordt onder plaatselijke verdoving het afdekdopje vervangen, zodat het afdekdopje (healing abutment) door het tandvlees heen komt en zichtbaar is. 2 weken hierna kan de tandarts beginnen met het maken van uw kroon of brug.

Soms wordt direct een healing cap (afdekdopje) op het implantaat geplaatst, welke zichtbaar is in de mond. De MKA-chirurg zal u dan de instructie geven om na 3-5 dagen te gaan starten met het poetsen over dit dopje. Het vastgroeien van het implantaat duurt ongeveer 2 tot 4 maanden.

Voorbeeld van een brug op 2 implantaten ©Astra

Na de operatie

Medicijnen

Voor de operaties krijgt u van de MKA-chirurg een advies voor een pijnstiller en een spoelvloeistof. Soms wordt ook een antibioticum voorgeschreven. Overleg vooraf met de MKA-chirurg over het gebruik van medicijnen die u normaal gesproken neemt. Als u bloedverdunners gebruikt, krijgt u hier instructies over.

Roken

Roken vertraagt de wondgenezing en maakt de mond extra vies. Roken verstoort het vastgroeien van de implantaten. Stop daarom – in elk geval een aantal weken voor de operatie – met roken.

Voeding

Nadat de implantaten zijn aangebracht, moeten deze vastgroeien in het kaakbot. Dit vastgroeien duurt 2 tot 3 maanden. In deze periode mogen de implantaten niet te zwaar worden belast. Daarom krijgt u het advies voor een dieet met zachtere voeding.

Mondverzorging

Goede mondverzorging is na de operatie erg belangrijk in verband met een goede genezing.

Spoel uw mond niet de eerste dag na de ingreep. Dit vergroot de kans op een nabloeding. Vanaf de tweede dag gaat u spoelen met een desinfecterend spoelmiddel (chloorhexidine) gedurende 2 weken. U heeft hiervoor een advies van uw MKA-chirurg gekregen.

Drie dagen na de operatie kunt u de afdekdopjes van de implantaten (als deze zichtbaar zijn) en het omliggende tandvlees weer zachtjes gaan poetsen met een tandenborstel.

Een goede reiniging is van groot belang voor gezond tandvlees en een lange levensduur van de implantaten. De mondhygiënist geeft u hier informatie over en helpt u de implantaten goed te reinigen.

Ook nadat uw kroon of brug is geplaatst, geeft de mondhygiënist u informatie hoe u deze het beste kunt reinigen.

Pijn

De plaatselijke verdoving is na 1 tot 3 uur uitgewerkt. U kunt dan pijn krijgen. Deze pijn is goed te bestrijden door het innemen van pijnstillers. U heeft hiervoor een advies gekregen van uw MKA-chirurg. U kunt het beste bij thuiskomst direct beginnen met de pijnstillers (voordat de plaatselijke verdoving helemaal is uitgewerkt).

Zwelling

Door de operatie kan een zwelling ontstaan. Deze zwelling is 2 dagen na de operatie het grootst en slinkt daarna langzaam. Dit is een normaal gevolg van de ingreep.

Nabloeding

Het eerste uur na de ingreep kan de wond nog een beetje bloeden. Dit gaat vanzelf over.
Ook kan het speeksel de eerste dag na de ingreep nog wat rood zijn.

Wanneer de wond opnieuw gaat bloeden of als het bloeden toeneemt, kunt u het volgende doen:

- U pakt een (steriel) gaasje of schone katoenen zakdoek en legt die opgevouwen op de (bloedende) wond.
- Daarna bijt u de kaak stijf dicht.
- Hou dit een half uur vol.

Het gaat erom dat er constante druk op de wond wordt uitgeoefend. Als het bloeden hierna niet gestopt is, belt u de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie van het HagaZiekenhuis.

Mogelijke bijwerkingen en risico's

Bij het aanbrengen van implantaten kunnen complicaties optreden, zoals een ontsteking van het kaakbot of tandvlees. Als gevolg van de operatie kunnen verder bijwerkingen optreden in de vorm van pijn, zwelling en bloeduitstortingen. Door het gebruik van een pijnstiller is de pijn vaak goed te onderdrukken.

Net na de operatie is het mogelijk dat u een geringe verhoging heeft. Als de koorts hoger wordt dan 39°C belt u het HagaZiekenhuis. Dat doet u ook als de zwelling en/of pijn toeneemt na 4 of 5 dagen.

Er bestaat een gering risico (kleiner dan 5 procent) dat een implantaat niet goed vastgroeit en moet worden verwijderd. Mocht dit noodzakelijk zijn, dan ontstaat weer dezelfde situatie als vóór het inbrengen van het implantaat. Dan overlegt de arts met u of er een nieuwe poging wordt gedaan om een implantaat aan te brengen of dat het beter is te zoeken naar een andere oplossing.

Controle

Nadat uw kroon of brug is geplaatst en u aan de nieuwe situatie gewend bent, komt u nog een keer terug bij de mondhygiëniste en MKA-chirurg voor controle. Eén jaar na plaatsen van de kroon of brug ziet de MKA-chirurg u voor de eindcontrole.

De verdere controles vinden daarna bij uw eigen tandarts plaats. Het advies is om het implantaat, het omliggende tandvlees en het kaakbot jaarlijks te laten controleren door de eigen tandarts.

Wat zijn de kosten?

- Implantaten ter vervanging van een of enkele tanden/kiezen worden meestal niet vergoed door de zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Informeer eerst bij uw zorgverzekeraar of in uw verzekering een vergoeding van de implantaten en/of het plaatsen van de kroon en/of brug zit, en hoe hoog die vergoeding is.
- Als u aanvullend verzekerd bent (voor tandheelkundige zorg), kunt u vaak een bedrag terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Dit bedrag is vaak niet geheel kostendekkend.
- Als uw verzekering de kosten niet (volledig) dekt, krijgt u van zowel de MKA-chirurg als de tandarts een kostenoverzicht voor de besproken behandeling. Als u akkoord gaat met het betalen van deze kosten, wordt een afspraak met u gemaakt voor de behandeling.
- 1 jaar nadat de suprastructuur (de kroon of brug) op het implantaat is geplaatst, zien wij u voor de laatste controle. Met deze laatste controle kunnen wij mogelijke problemen met betrekking tot het implantaat signaleren en in een vroeg stadium bijsturen. Op deze manier dragen wij bij aan een duurzaam behandelresultaat. Ook volgen we hiermee de aanbevelingen van de Nederlandse Vereniging voor Orale Implantologie (NVOI). Er zal bij deze laatste afspraak een consult worden uitgevoerd en zo nodig een röntgenfoto worden gemaakt. Deze kosten worden in rekening gebracht. Het kan zijn dat hiermee uw eigen risico wordt aangesproken. Als u in het bezit bent van een recente röntgenfoto, zou u dan zo vriendelijke willen zijn om deze mee te nemen? (deze dient wel voorzien te zijn van uw naam en geboortedatum).

Contactgegevens

HagaZiekenhuis Den Haag

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek is bereikbaar:

- van maandag tot en met vrijdag
- van 8.00-17.00 uur
- telefoon (070) 210 6710

Buiten bovengenoemde uren neemt u voor spoedeisende zaken contact op met de Spoedeisende Hulp, telefoon: (070)2102060.

HagaZiekenhuis Zoetermeer

De Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie Polikliniek is bereikbaar:

- van maandag tot en met donderdag
- van 8.00-16.30 uur
- telefoon (079) 346 4355

Buiten bovengenoemde uren neemt u voor spoedeisende zaken contact op met de Spoedeisende Hulp, telefoon: (079) 346 2539.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.

106724112025